Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
5ª Vara Cível da Comarca de Caxias do Sul

Rua Dr. Montaury, 2107, 4° andar - Bairro: Exposição - CEP: 95020190 - Fone: (54) 996790955 - Email: frcaxsul5vciv@tjrs.jus.br

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 5042751-22.2023.8.21.0010/RS

AUTOR: MARI ROGERIA MENEGUZZI

RÉU: UNIMED GRANDE FLORIANOPOLIS - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

SENTENÇA

Vistos, etc.

MARI ROGERIA MENEGUZZI, parte qualificada no processo, por meio de seu procurador, ajuizou "ação de obrigação de fazer c/c danos morais com pedido de tutela de urgência" contra **UNIMED GRANDE FLORIANOPOLIS - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO**, parte também qualificada.

A parte autora narrou ser beneficiária do plano de saúde fornecido pela parte ré. Suscitou ser portadora de asma severa eosinofílica (CID 10 J45.0), sofrendo com crises recorrentes de tosse e broncoespasmo, necessitando custear a medicação e o tratamento adequado para não agravar o quadro da doença. Referiu que já realiza tratamento de longa, entretanto, os sintomas permaneceram. Desta forma, a resposta clínica foi insuficiente, os remédios já utilizados são ineficientes para melhora de seu quadro clínico. Sustentou que o novo tratamento recomendado consiste na utilização do medicamento Dupilumabe *(DUPIXENT)*, na dose de 200mg a cada 14 dias, além da dose de ataque de 400mg, em ambiente hospitalar ou clínica, sob supervisão médica (anexos 5/9, do Evento 1). Devido ao alto custo da medicação, não se vê possibilitada de adquiri-lo por meios próprios, motivo pelo qual o requereu de forma administrativa à operadora de saúde ré, contudo, não obteve êxito, eis que o fornecimento foi negado. Solicitou a reanálise do seu pedido, informando que a medicação requerida possui cobertura obrigatória para o tratamento da asma grave do rol da ANS, sendo que novamente o fornecimento foi negado, sob o argumento de que o plano foi contrato anteriormente à 1999 e não estaria submetido à Resolução Normativa - RN Nº 465 (anexos 9/13, do Evento 1). Entende ser vítima de vítima de falha na prestação do serviço, pois a operadora do plano de saúde requerida negou a cobertura de medicação que está prevista no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) de cobertura obrigatória dos medicamentos. Invocou a aplicação do Código de Proteção e de Defesa do Consumidor. Discorreu sobre a matéria que entende pertinente ao direito invocado. Pleiteou, em sede de tutela de urgência, a determinação para que a requerida seja compelida a fornecer à autora o medicamento Dupilumabe na dose de 200mg, para aplicação a cada 14 dias, por tempo indeterminado, além da dose de ataque de 400mg. Postulou a inversão do ônus da prova. Pediu julgamento procedente, para fins de: a) confirmar o pleito liminar, condenando a parte ré à fornecer o medicamento Dupilumabe 200mg, para aplicação a cada 14 dias, bem como a dose de ataque de 400mg, conforme prescrição médica, ininterruptamente à autora, e; b) condenar a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais, em valor não inferior a R$ 10.000,00. Deu à causa o valor de R$ 20.533,13. Juntou procuração e documentos.

Através de manifestação, a autora informou ter realizado o pagamento das custas iniciais- evento 4, DOC1.

O pleito liminar foi deferido, determinando que a demandada custeie o tratamento, devendo disponibilizar à autora, no prazo de sete dias, o medicamento Dupilumabe 200mg, para aplicação a cada 14 dias, por tempo indeterminado, além da dose de ataque de 400mg, podendo ser ministrado o medicamento na unidade de Caxias do Sul/RS, sob pena de multa diária de R$ 2.500,00, consolidada, a princípio, em trinta dias- evento 6, DOC1.

Através de manifestação, a parte requerida informou o cumprimento da decisão liminar - evento 19, DOC1.

Citada, a demandada apresentou contestação (evento 21, DOC1). Requereu, preliminarmente, o reconhecimento de que o contrato cuja parte autora encontra-se vinculada é não regulamentado pela Lei 9.656/98 e, deste modo, as negativas e demais deliberações são pautadas no acordo celebrado entre as partes na época de sua assinatura. Ademais, alegou que realizou a oferta de adaptação à autora em duas oportunidades, no ano de 2016 e em 2022, no entanto, essa deixou de manifestar qualquer interesse na adaptação, mantendo-se inerte. No mérito, arguiu que a demandante é beneficiária do plano de saúde vinculado à parte ré, *"Módulo Básico - Pessoa Física"*, com vigência em 06-05-1994 (evento 21, DOC2), não regulamentado pela Lei 9.656/98 e, consequentemente, não segue as determinações da Resolução Normativa – RN n.º 465/2021, instituída pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), que estabelece o Rol de procedimentos e eventos em saúde de cobertura obrigatória nos planos de saúde privados. O tratamento indicado pelo médico assistente à autora, possui previsão no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, todavia, como o contrato firmado não foi adaptado à Lei 9.656/98, inexistindo a obrigação da parte em fornecer o medicamento Dupilumabe 200mg, uma vez que há expressa exclusão contratual de fornecimento, eis que vacinas e medicamentos, salvo nos casos de internação, não possuem cobertura. Não tem cabimento o pleito que busca o recebimento de valores a título indenizatório. Discorreu acerca da inexistência de abusividade contratual, arguindo que o dever de prestação universal a saúde é apenas do Estado. Alegou ser incabível, no presente caso, a inversão do ônus probatório. Por fim, impugnou os documentos colacionados pela parte autora, junto à exordial, em especial os laudos apresentados, eis que formulados unilateralmente. Pediu julgamento improcedente. Juntou procuração e documentos.

A parte requerida interpôs agravo de instrumento, frente a decisão que deferiu a tutela de urgência requerida pela autora, o qual foi provido, revogando o pleito liminar concedido anteriormente- evento 18, DOC2.

Apresentada réplica- evento 27, DOC1.

Intimadas as partes quanto ao interesse na produção de outras provas- evento 29, DOC1. Ambas manifestaram desinteresse- evento 33, DOC1 e evento 36, DOC1.

Relatei. Decido.

Preliminarmente:

Do Contrato Celebrado Não Regulamentado Pela Lei 9.656/98:

A preliminar sobre o argumento de que o contrato cuja autora encontra-se vinculada é não regulamentado pela Lei 9.656/98 e, deste modo, as negativas e demais deliberações são pautadas no acordo celebrado entre as partes na época de sua assinatura, e que fora realiza, em duas ocasiões, a oferta de adaptação à autora, sendo que esta manteve-se inerte, se confunde com o mérito, por isso vai desde já rejeitada.

No Mérito:

Considerações iniciais:

O contrato de prestação de serviços entabulado entre o demandante e a requerida envolve relação de consumo; consubstancia típico contrato de adesão. Assim, entendo aplicáveis ao caso sob exame os preceitos do Código de Proteção e de Defesa do Consumidor, especificamente em seu artigo 47, que prevê que as cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor – o hipossuficiente da relação. Ademais, como consequência, surge a possibilidade de haver intervenção do Poder Judiciário para fins de declarar, inclusive de ofício, a nulidade de cláusulas que ferem os direitos assegurados no aludido diploma legal.

Relevante salientar, ainda, que o objeto principal do pacto é a cobertura do risco contratado, ou seja, o evento futuro e incerto que poderá gerar o dever de indenizar por parte do segurador. E, outro e relevante elemento essencial do contrato em análise é a boa-fé, prevista no art. 422 da atual legislação civil, que tem como uma de suas consequências o dever de prestar informações adequadas quanto ao pacto avençado.

Pelas provas acostadas à presente demanda, em especial os prontuários médicos e receituários (anexos 7/9 e 12, todos do Evento 1), restou evidente a necessidade da realização do tratamento com utilização do fármaco Dupilumabe 200mg, para aplicação a cada 14 dias, bem como a dose de ataque de 400mg, cujo fornecimento foi pleiteado pela parte autora.

Observe-se que apesar de o contrato de plano de saúde celebrado entre as partes não ter sido adaptado à Lei n. 9.656/98, isto não afasta a incidência do aludido diploma legal, por se cuidar de norma de interesse público, com aplicação imediata, em relações marcadas pela continuidade que, a despeito de nascidas em período anterior à sua vigência, devem sofrer os efeitos da nova lei.

No mesmo sentido, os seguintes arestos. Leia-se:

> *"APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. PLANO DE SAÚDE.* ***AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. NEGATIVA DE COBERTURA. CONTRATO NÃO REGULAMENTADO.*** *INAPLICABILIDADE DA LEI 9.656/98. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. COBERTURA DEVIDA. 1.* ***AINDA QUE INAPLICÁVEL A LEI 9.656/98 AOS CONTRATOS DE PLANO DE SAÚDE FIRMADOS EM DATA ANTERIOR, A QUESTÃO DEVE SER APRECIADA À LUZ DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (SÚMULA 608 DO STJ), COM INTERPRETAÇÃO MAIS BENÉFICA AOS ADERENTES*** *CONFORME (ART. 47 DO CDC). 2.* ***O PLANO DE SAÚDE NÃO PODE SE RECUSAR A CUSTEAR TRATAMENTO PRESCRITO PELO MÉDICO, POIS CABE A ESTE DEFINIR QUAL É O MAIS INDICADO PARA O SEGURADO. ALÉM DISSO, O QUE IMPORTA É A EXISTÊNCIA DE COBERTURA DO CONTRATO PARA A DOENÇA APRESENTADA PELA PARTE AUTORA, NÃO IMPORTANDO A FORMA COMO O TRATAMENTO SERÁ MINISTRADO.*** *3. NOS TERMOS DO ART. 51, IV, DO CDC, MOSTRA-SE ABUSIVA A CLÁUSULA CONTRATUAL QUE EXCLUI DO TRATAMENTO O FÁRMACO PLEITEADO, UMA VEZ QUE COLOCA O CONSUMIDOR EM DESVANTAGEM EXAGERADA FRENTE À OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. RECURSO DESPROVIDO. (Apelação Cível, Nº 50003585520208210150, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em: 29-11-2023)"* (Destaquei).

Não obstante, válido salientar que a referida decisão trata somente da alegação apresentada pela instituição requerida, no sentido de que o contrato cuja autora encontra-se vinculada é não regulamentado pela Lei 9.656/98 e, deste modo, as negativas apresentadas são pautadas no acordo celebrado entre as partes na época de sua assinatura.

Isto posto, em relação ao fornecimento do fármaco pleiteado, este Magistrado adota o entendimento consolidado pela Terceira e Quarta Turma do STJ (Resp n.º 1.692.938 - 3ª Turma e n.º 1.883.654 - 4ª Turma) no sentido de que **os planos de saúde não estão obrigados a fornecer medicamento de uso domiciliar**, como previsto no artigo 10 da lei 9656/981, exceto os relativos ao tratamento de câncer, que são de fornecimento obrigatório em razão de expressa disposição legal (lei 12.880/2013) e os previstos no Rol da ANS.

Acerca da obrigação de fornecimento da aludida medicação, não destoa o entendimento do Tribunal de Justiça do estado do Rio Grande do Sul. Leia-se:

> *"APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DERMATITE (CID10). TRATAMENTO DOMICILIAR. RECUSA/NEGATIVA DEVIDA DE CUSTEIO. - Em overruling passa-se a adotar o entendimento do STJ de*

que a ANS realiza verdadeira regulamentação infralegal, a qual decorre de expressa delegação legal de competência e constitui relevante garantia do contratante para assegurar direito à saúde, pois evita a padronização de todos os planos de saúde, impedindo restrição à livre concorrência e, ainda, prima pela autonomia e preservação do equilíbrio contratual e atuarial perante as operadoras. - Assim, as decisões judiciais devem observar o fornecimento de tratamentos/próteses/órteses obrigatórios, os destinados aos tratamentos de doenças expressamente contratados e que sejam autorizados pela ANS, para o tratamento a ser realizado, mesmo quando recentemente inseridos no Rol da Agência. - ***No caso, a parte autora/recorrente foi diagnosticada com dermatite atópica ou eczema atópico (CID10 – L20), necessitando de tratamento contínuo de uso domiciliar do medicamento DUPILUMABE ou DUPIXENT 300 mg dosagem de indução, seguida de 300mg a cada 14 dias, por período indeterminado. - Assim, por se tratar de medicamentos de uso domiciliar, para utilização fora da unidade de saúde, não há falar em cobertura contratual, tampouco legal****, conforme previsão expressa do artigo 10, inciso VI, da Lei nº 9.656/98, e da RN nº 465/2021. - Sentença objurgada que vai ao encontro do entendimento da Terceira e Quarta Turmas do STJ (Resp n.º 1.692.938 - 3ª Turma e n.º 1.883.654 - 4ª Turma)* ***no sentido de que os planos de saúde não estão obrigados ao fornecimento de medicamento de uso domiciliar,*** *como previsto no artigo 10 da lei 9656/981, exceto os relativos ao tratamento de câncer, que são de fornecimento obrigatório em razão de expressa disposição legal (lei 12.880/2013) e os previstos no Rol da ANS. APELO PROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível, Nº 50347129720228210001, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Julgado em: 31-08-2023)"*

Destaco que o medicamento pleiteado (DUPILUMABE) é de uso domiciliar, conforme consta em seu registro perante a ANVISA, extraindo-se, da denominada "Bula do Paciente", o seguinte:

Você pode auto injetar DUPIXENT ou pode ser administrado por um profissional de saúde ou administrado por um cuidador após receber treinamento apropriado de um profissional de saúde, com relação à preparação e administração de DUPIXENT antes do uso, de acordo com o Folheto de Instruções de Uso (fornecido com o medicamento).
Use sempre este medicamento exatamente como seu médico ou farmacêutico lhe orientou. Verifique com seu médico ou farmacêutico se você não tiver certeza.
Você e seu médico ou enfermeiro devem decidir se você deve injetar DUPIXENT em você mesmo.
Cada seringa preenchida contém uma dose de DUPIXENT. Não agite a seringa preenchida.
Leia atentamente as "Instruções de Uso" para a seringa preenchida antes de usar DUPIXENT.
DUPIXENT é autoadministrado através de injeção subcutânea na coxa ou abdômen, exceto nos 5 cm ao redor do umbigo, utilizando uma seringa preenchida de uso único. Se outra pessoa for administrar a injeção, ela também pode ser aplicada na parte superior do braço.

(*https://consultas.anvisa.gov.br/#/bulario/q/?numeroRegistro=183260335*)

Assim, por se tratar de medicamentos de uso domiciliar, para utilização fora da unidade de saúde, não há falar em cobertura contratual, tampouco legal, pelo que a improcedência total da presente ação é medida que se impõe, sentido no qual ora decido.

DIANTE DO EXPOSTO, julgo IMPROCEDENTE a presente "ação de obrigação de fazer c/c danos morais com pedido de tutela de urgência" ajuizada por **MARI ROGERIA MENEGUZZI** contra **UNIMED GRANDE FLORIANOPOLIS - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO**, o que faço com fundamento nas razões e dispositivos legais supracitados.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais e de honorários advocatícios em prol do patrono da parte adversa, ora fixados em 10% sobre o valor da causa, atualizado. Exegese do artigo 85, § 2.º, do CPC.

Havendo recurso, após processado, remeta-se ao TJRS. Caso contrário, arquive-se.

Caxias do Sul, 08 de janeiro de 2.024.

Documento assinado eletronicamente por **SILVIO VIEZZER, Juiz de Direito**, em 8/1/2024, às 17:3:19, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc1g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, informando o código verificador **10051357181v25** e o código CRC **497b6dfc**.